UE C1 · Santé publique, promotion et prévention

CM2 · Panorama de la santé et inégalités

Lire un état de santé : plusieurs indicateurs

Espérance de vie, mortalité évitable, maladies chroniques, état de santé ressenti et qualité des soins décrivent des aspects différents. Comparer des populations exige âge, période, définition et source comparables.

Les facteurs de risque incluent tabac, alcool, alimentation et sédentarité ; logement, revenus, éducation, environnement et accès aux services pèsent aussi sur la santé.

Un chiffre moyen national peut masquer des écarts sociaux ou territoriaux importants.

Inégalités sociales de santé

Écarts systématiques de santé entre groupes selon leur position sociale : ils se distribuent souvent en gradient, au-delà des seules situations de grande précarité.

Exposition aux risques, ressources disponibles, conditions de vie, possibilités de prévention et accès effectif aux soins se cumulent au fil du parcours de vie.

Différencier égalité (même offre) et équité (réponse adaptée aux besoins pour réduire les écarts).

Besoins de santé : quatre portes d’entrée

Normatif : défini par un professionnel ou une norme. Ressenti : éprouvé par la personne. Exprimé : transformé en demande. Comparatif : mis en évidence entre groupes similaires.

Croiser les données épidémiologiques avec la parole des personnes évite de confondre absence de demande et absence de besoin.

CM2 · Accès aux soins et littératie

De l’offre à l’accès réel

Un service peut exister sans être accessible : disponibilité, distance, horaires, coût, démarches, langue, accueil et acceptabilité sont autant d’obstacles.

Repérer la précarité, l’isolement et les difficultés de compréhension ; adapter, orienter et coordonner avec les ressources sanitaires et sociales.

Littératie en santé : agir sur la compréhension

Capacité à accéder à une information de santé, la comprendre, l’évaluer et l’utiliser pour décider et agir. Elle dépend aussi de la clarté des professionnels et des systèmes.

Message court et priorisé ; mots familiers, supports visuels et exemples ; parler par étapes et faire reformuler sans mettre la personne en échec.

Pour les nombres : préférer des repères concrets et un schéma. Adapter l’éducation à la personne, puis vérifier la compréhension et réajuster.

Rôle IDE : ne pas amplifier les écarts

REPÉRER les vulnérabilités et barrières → ADAPTER la relation et les informations → ORIENTER / COORDONNER → VÉRIFIER que l’intervention bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin.

Exemple : remettre une notice ne suffit pas si la personne ne peut ni la comprendre ni accéder au soin proposé.